01 · Mesurer et interpréter

Réflexe IDE : Identité → bon matériel → bonne technique → mesure → comparaison → alerte → traçabilité.

Valeurs adultes au repos : T° ~36,5–37,5 °C ; FR 12–20/min ; FC 60–100/min ; SpO_2 habituelle ≥95 % en air ; la PA se compare à l'habitude.

Paramètre	Observation associée
FR / SpO_2	Effort ventilatoire, cyanose, état neuro.
FC / PA	Rythme, pouls, perfusion, position.
T°	Site, heure, frissons, sueurs.
Diurèse	Volume, mL/kg/h, entrées/sorties.

Ne jamais conclure sur un seul chiffre. Une personne peut se dégrader avant que la PA ne baisse.

02 · Cadre légal 2026 / stage

Rôle propre : évaluer, surveiller, interpréter, alerter et tracer. Arrêté du 26 juin 2026 (art. 1).

Réalisation confiée : selon les conditions réglementaires, un AS ou AP peut recueillir certains paramètres, dont la glycémie capillaire. L'IDE analyse le résultat et assume son suivi (art. 2).

Sur prescription : certains prélèvements, médicaments et actes invasifs (art. 4 et 5).

> **En tant qu'ESI :** signaler au référent toute valeur ou situation incohérente ; ne pas effectuer seul un geste non autorisé. Toujours vérifier le protocole.

03 · Température / thermorégulation

Situation	Repère
Fièvre	≥ 38 °C au repos
Hypothermie	< 35 °C
Coup de chaleur	Souvent >40 °C + atteinte neurologique : urgence

Fièvre : hypothalamus augmente le point de consigne. Ascension : frissons ; plateau : chaud ; défervescence : sueurs.

Hyperthermie : chaleur excessive, sans consigne augmentée ; refroidissement physique et alerte si signes de gravité.

Stage : même site et matériel ; tracer valeur, voie, heure, antipyrétique. Détecter confusion, marbrures, polypnée et hypotension.

04 · Fièvre : adulte et enfant

Sites : axillaire (sous-estimation), tympanique (placement), buccal (boisson/repas), frontal (variable), rectal (invasif). Ne pas « ajouter » arbitrairement 0,5 °C.

Enfant : fièvre centrale >38 °C (HAS 2016). Objectif : améliorer le confort, faire boire, ne pas surcouvrir.

> **Alerte immédiate :** enfant < 3 mois fébrile ; purpura, altération conscience, difficulté respiratoire, teint gris/cyanose.

Paracétamol pédiatrique : maxi habituel 60 mg/kg/j, par 4 à 6 prises, sous prescription/protocole avec vérification RCP, âge et poids.

05 · FR : observer 1 minute

Termes	Sens
Eupnée	Respiration normale
Tachypnée	FR trop élevée pour âge
Bradypnée	FR trop basse pour âge
Dyspnée	Gêne respiratoire
Orthopnée	Mieux assis
Apnée	Arrêt respiratoire

Adulte : FR 12–20/min au repos ; compter discrètement pendant 60 s, observer symétrie, amplitude et rythme.

Urgence : FR ≥25 ou ≤8/min, tirage, stridor, cyanose, confusion, incapacité de finir une phrase.

06 · SpO_2 et oxygène

SpO_2 : saturation pulsée, pas mesure du CO_2 ni de la ventilation. Adulte sain en air : en général ≥95 %.

Cible sous O_2 : souvent 94–98 %. Si insuffisance respiratoire hypercapnique et cible prescrite : 88–92 %. Individualiser.

Erreurs : froid, vasoconstriction, mouvement, vernis, mauvaise courbe, pigments ; monoxyde de carbone : SpO_2 trompeuse.

> **Tracer :** « 94 % à l'air ambiant » ou « 95 % sous O_2 2 L/min lunettes » + FR, signes cliniques et tendance.

07 · Pouls et fréquence cardiaque

Adulte	Repères
Normale au repos	60–100/min
Tachycardie	>100/min
Bradycardie	<60/min (contexte !)
Arythmie	Rythme irrégulier

Pouls radial : index + majeur ; jamais pouce. Surveiller fréquence, régularité, amplitude, symétrie. Compter 60 s si irrégulier.

À chercher : fièvre, douleur, hypovolémie, hypoxie, médicaments (bêtabloquants), hémorragie.

> **Astuce :** un pouls très rapide et filant + peau froide et confusion = alerte même si la PA reste normale.

08 · PA : bien mesurer

PAS = systole ; **PAD** = diastole ; **PAM** ≈ PAD + (PAS − PAD)/3.

Technique : repos ≥5 min ; bras nu à hauteur du cœur ; dos soutenu, pieds à plat ; brassard adapté ; 2 mesures ; noter bras/position.

Situation adulte	Repère
HTA en consultation	≥140/90 mmHg, à confirmer
Hypotension	PAS <90 ou chute importante
Orthostatique	PAS −20 ou PAD −10 mmHg debout
PAM critique	<65 mmHg selon contexte

Ne pas mesurer sans évaluation : fistule AV, lymphœdème, perfusion, traumatisme. Tenir compte des antécédents et du protocole.

09 · Douleur et conscience

Douleur : EN 0–10, EVA ou EVS si possible ; Algoplus/EVENDOL si autoévaluation impossible. Réévaluer après analgésie.

ACVPU : A = alerte ; C = confusion nouvelle ; V = voix ; P = douleur ; U = aucune réponse.

Glasgow : yeux (1–4) + verbal (1–5) + moteur (1–6) = 3 à 15. ≤8 : gravité neurologique majeure.

> **Alerte :** changement soudain de conscience, trouble pupillaire, convulsions, douleur thoracique, céphalée brutale inhabituelle.

10 · Diurèse / bandelette

Terme adulte	Repère
Oligurie	<0,5 mL/kg/h plusieurs heures
Anurie	<100 mL/24h
Polyurie	>3 L/24h
Rétention	Vessie pleine sans vidange

BU : leucocytes/nitrites (évoquent infection), protéines, sang, glucose, cétones, pH, densité. Lire au délai du fabricant.

Attention : BU positive ≠ infection certaine, notamment en absence de symptômes. Tracer, contextualiser, alerter.

11 · Glycémie / capteur

Repère	Valeur
Hypoglycémie	<0,70 g/L
Niveau 2	<0,54 g/L
Équivalence	1 g/L ≈ 5,55 mmol/L
Glycémie à jeun ≥1,26 g/L	Diabète à confirmer au labo

Capillaire : mains propres et sèches, piqûre latérale, ne pas presser fortement, tracer repas et symptômes.

Capteur : glucose interstitiel (retard possible lors de variations rapides). En établissement et si discordance, contrôle capillaire selon protocole.

Hypoglycémie symptomatique : agir sans attendre selon état de conscience et protocole ; jamais de boisson sucrée si déglutition non sûre.

12 · Poids / taille / IMC

IMC : poids (kg) ÷ taille² (m²). 18,5–24,9 : intervalle de référence adulte ; ≥25 : surpoids ; ≥30 : obésité.

Poids : même balance, même moment, tenue comparable. 1 kg pris rapidement peut traduire environ 1 L de rétention hydrique.

Enfant : ne jamais utiliser les seuils adultes ; examiner courbes de croissance et périmètre crânien.

Stage : suivre variation quotidienne si prescription (ex. insuffisance cardiaque), diurèse, œdèmes, apports, symptômes.

13 · NEWS2 : score adulte

7 composantes : FR, SpO_2, O_2, PAS, FC, conscience, T°. Noter aussi la tendance.

Score NEWS2	Réaction indicative
0	Surveillance habituelle
1–4	Évaluation IDE
3 sur un critère	Avis médical rapide
5–6	Réponse urgente
≥7	Réponse d’urgence critique

SpO_2 échelle 2 : seulement si insuffisance respiratoire hypercapnique documentée sur décision médicale. Pas automatiquement toute BPCO.

IMPORTANT : un score bas n’interdit jamais d’alerter ; NEWS2 ne remplace pas le jugement clinique, et ne s’applique pas aux enfants.

14 · SAED : transmission

Étape	Contenu
S — Situation	Qui / qui / pourquoi maintenant ?
A — Antécédents	Motif, pathologies, traitements
E — Évaluation	Paramètres, évolution, score, actions
D — Demande	Ce que j’attends, délai, reformulation

Exemple : « M. R. se dégrade, J2 PTH, T 38,4 ; FR 22 ; FC 104 ; PA 105/62 ; SpO_2 94 % en air, NEWS2 6. Pouvez-vous le voir rapidement ? »

Tracer : heure, interlocuteur, informations, décisions, surveillance et réévaluation.

15 · Pédiatrie : repères

Âge	FC	FR	PAS basse
Nouveau-né	90–180	40–60	<60
1 an	80–160	20–30	<72
2 ans	80–140	20–28	<74
6 ans	75–115	18–24	<82
>10 ans	≈60–110	16–20	<90

Signes inquiétants : tirage, geignement, hypotonie, somnolence, TRC prolongé, refus de boire, purpura, changement de comportement.

Rappel : valeurs selon âge, activité, sommeil ; la PA basse arrive tard. Utiliser un score pédiatrique adapté (PEWS), pas NEWS2.

16 · Mini-quiz corrigé

1. PAM à 105/62 ? **2.** FR adulte 28/min ? **3.** Oligurie à 70 kg : quel seuil horaire ? **4.** ACVPU : « C » ? **5.** SpO_2 98 % sous O_2 et FR 6/min : rassurant ?

Réponses : 1. 62+(105−62)/3 ≈ **76 mmHg**. 2. Tachypnée, signe d'alerte. 3. **35 mL/h**. 4. Confusion nouvelle. 5. Non : hypoventilation possible, alerte immédiate.

> **À réciter :** « Je mesure, je vérifie, je compare, je croise, j'alerte et je trace. »

Sources : CM Swinnen (71 diapos), Légifrance (2025–2026), HAS fièvre enfant (2016) et SAED (2014), RCP NEWS2 (2017). Version 14/10/2026.